HEMICOLECTOMÍA DERECHA

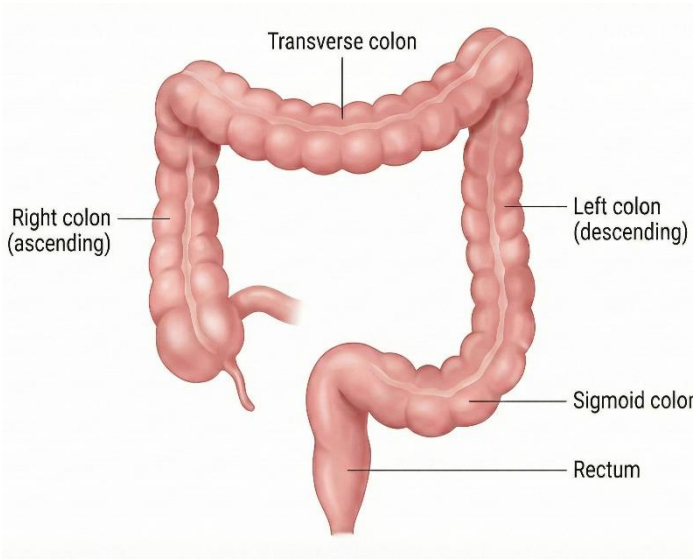
Mª Elisa de Castro Peraza, Judith Reguera Cabrera, María Pérez López, Lidia García González, Mª Elba Palomares Ramos, Nieves Lorenzo Rocha

DEFINICIÓN Y OBJETIVOS

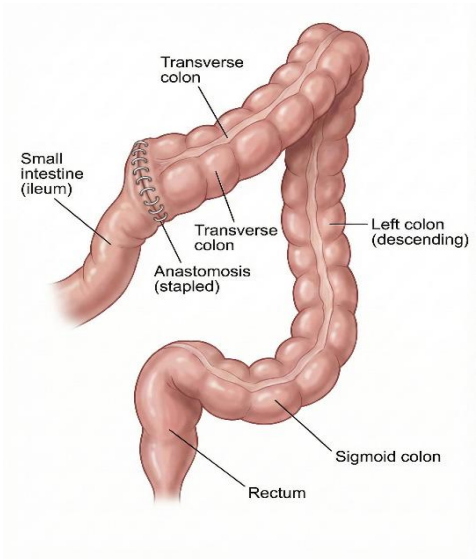
La colectomía hace referencia a la extirpación quirúrgica de una parte enferma del colon.

- Si la parte resecada incluye la extirpación del ciego, colon ascendente, ángulo hepático y parte del colon transverso, hablamos de hemicolectomía o colectomía derecha. En este caso, tras la resección se establecerá una anastomosis entre el intestino delgado y el extremo sano del intestino grueso.
- Si la resección es más amplia e incluye la sección de la arteria y vena cólica media, se habla de colectomía derecha ampliada o extendida.

Una de las principales indicaciones de estas técnicas es la exéresis de tumores, aunque también se pueden intervenir otro tipo de patologías como la poliposis, la angiodisplasia o la enfermedad inflamatoria intestinal (EII).



Anatomía normal



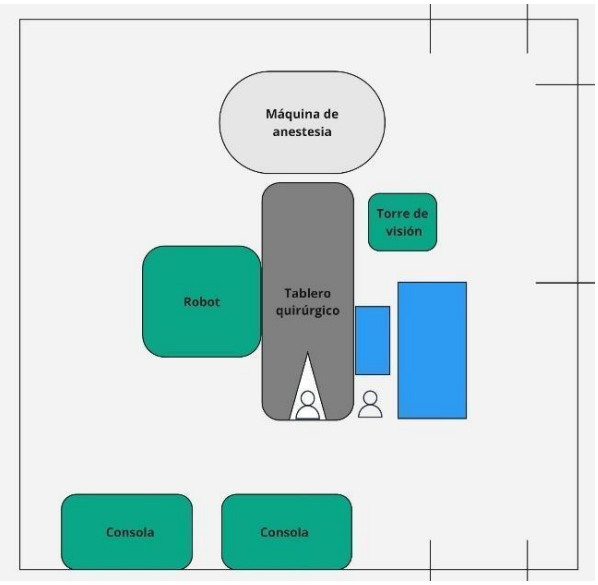
Hemicolectomía derecha

POSICIÓN QUIRÚRGICA DEL PACIENTE

- Decúbito supino con los brazos alineados.
- Perneras bajas en aducción.
- Almohada de silicona para la cabeza.

POSICIÓN DEL EQUIPO QUIRÚRGICO Y CONFIGURACIÓN DEL DA VINCI

- Anatomía: abdominal inferior (aunque también se puede usar "abdominal superior" en el caso de abordaje subileal).
- Lado: derecho
  - Brazo 1: Tip-up
  - Brazo 2: Bipolar fenestrada
  - Brazo 3: Óptica de 30°
  - Brazo 4: Tijera / Vessel-sealer / Hem-o-lok
- Tablero quirúrgico:
  - Trendelemburg 10°-25°
  - Side izquierdo 5°−12°
  - Perneras bajas -10°



TÉCNICA QUIRÚRGICA

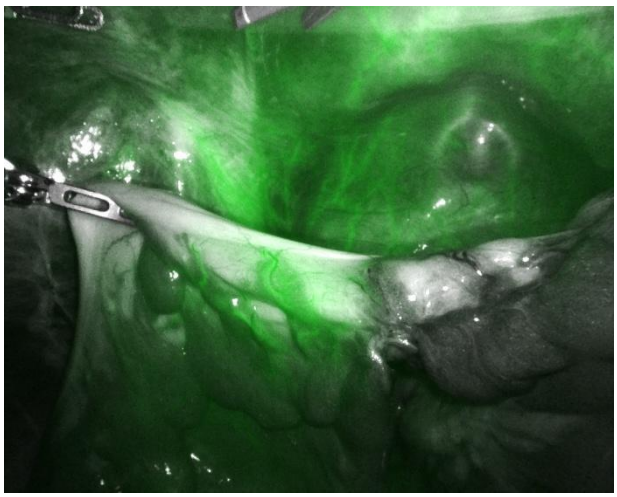
La técnica que se describirá en este capítulo es el abordaje *subileal*.

- Colocación de campo quirúrgico y trócares.
- Revisión de la cavidad y resección de adherencias. La revisión puede ser laparoscópica antes del acople del robot, por lo que es conveniente tener dos pinzas tipo grasper montados desde el inicio.

- Localización del íleon terminal mediante tracción del colon hacia la pared abdominal.
- Apertura del peritoneo sobre los vasos, disección hasta encontrar la arteria y la vena ileocólica, y sección con hem-o-lok DV.



- Seguidamente se repite proceso con los vasos cólicos derechos.
- Disección retroperitoneal, levantando el mesocolon hasta identificar el duodeno y llegar al reborde hepático.
- Liberación del duodeno y cabeza de páncreas.
- Se libera el epiplon del colon hasta llegar al ángulo hepático.
- Se tracciona del ángulo ileocecal para liberar el íleon distal y el ciego. En este paso es posible visualizar los vasos iliacos y el uréter derecho, estructuras cuya integridad hay que mantener.
- Se comprueba la vascularización del intestino con verde de indocianina para identificar el nivel de sección manteniendo una correcta perfusión de la anastomosis.
- Una posible aplicación del verde de indocianina sería: diluir 25 mg (un vial) en 10cc de agua bidestilada.



- Se suele inyectar la mitad de la dosis, es decir, 12.5 mg. Es conveniente arrastrar con un bolo de suero fisiológico la indocianina e inyectarle en una vía lo más proximal posible. Hay que tener cuidado con la dosificación máxima en pacientes especialmente susceptibles: mala función hepática, cardiópatas, etc. Respetando la recomendación de farmacia, no se deben administrar cantidades mayores a 0.3 mg/kg en pacientes cardiópatas y 0.5mg/kg en patologías hepáticas.

- Con el colon completamente liberado, se procede a la sección del colon transverso y del íleon distal con endograpadora Sureform.
- Se realiza asistencia para extraer la pieza y se vuelve al tiempo robótico para hacer la anastomosis.
- Se realiza anastomosis latero-lateral mecánica y con sutura tipo monocryl 3-0 cortado a unos 15cm.
- Colocación de drenaje, comprobación de hemostasia y cierre de heridas.

BIBLIOGRAFÍA

1. Zheng, J., Zhao, S., Chen, W. et al. Comparison of robotic right colectomy and laparoscopic right colectomy: a systematic review and meta-analysis. Tech Coloproctol. 2023; 27: 521–535. https://doi.org/10.1007/s10151-023-02821-2